Questões Objetivas — TN II

20 questões baseadas exclusivamente nos slides. Questões 1–8: nefropatias · 9–20: doenças hepáticas. Gabarito comentado ao final.

Questão 1. Paciente de 18 anos é internado com edema de membros inferiores, albumina de 2,5 g/dL, colesterol total de 460 mg/dL e proteinúria maciça, com diagnóstico de síndrome nefrótica. Considerando a tríade do manejo nutricional apresentada em aula, a conduta mais adequada é:

A) Dieta hiperproteica, para repor a albumina perdida na urina e corrigir o edema.
B) Restrição proteica a 0,28–0,43 g/kg/dia com cetoácidos, para reduzir a proteinúria.
C) Dieta normoproteica, com lipídios < 30% do VET, restrição de ácidos graxos saturados e alto consumo de fibras.
D) Dieta normoproteica, com lipídios entre 30% e 35% do VET e restrição hídrica de 1.000 mL.
E) Dieta hiperproteica e hipolipídica, já que a dislipidemia ocorre em menos de 30% dos pacientes.

Questão 2. Um paciente apresenta, há 4 meses, TFG de 52 mL/min/1,73 m² e relação albumina/creatinina urinária de 150 mg/g. Segundo o KDIGO 2012, a classificação correta é:

A) DRC G2 A2, com risco moderadamente aumentado.
B) DRC G3a A2.
C) DRC G3b A3.
D) Não é DRC, pois a TFG está acima de 30 mL/min/1,73 m².
E) DRC G3a A1, pois a albuminúria só é considerada alterada acima de 300 mg/g.

Questão 3. Sobre as estratégias de restrição proteica na DRC não dialítica (KDOQI 2020) apresentadas em aula, assinale a alternativa correta:

A) A dieta com 0,3–0,4 g/kg/dia suplementada com cetoanálogos (opção 02) é indicada para pacientes nos estágios 3, 4 ou 5.
B) Ambas as opções podem ser aplicadas a pacientes com diabetes, desde que metabolicamente estáveis.
C) Na opção 02, usa-se 1 comprimido de cetoanálogo para cada 5 kg de peso por dia; os cetoácidos recebem nitrogênio por transaminação hepática, formando aminoácidos essenciais e reduzindo a formação de compostos tóxicos.
D) A restrição proteica pode ser iniciada em paciente internado há uma semana por pneumonia, desde que ele não esteja desnutrido.
E) Os cetoácidos aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a síntese de ureia, o que justifica seu uso em estágios avançados.

Questão 4. Comparando as recomendações nutricionais para hemodiálise (HD) e diálise peritoneal (DP), assinale a alternativa correta:

A) O Kt/V de referência é 1,2 por sessão tanto na HD quanto na DP ambulatorial contínua.
B) A recomendação de proteína na HD (1,2–1,3 g/kg/dia) é maior que na DP, pela perda de aminoácidos no dialisador.
C) A recomendação de fósforo na HD (1.000–1.200 mg) é maior que na DP, pelo uso de quelantes.
D) Na DP, a oferta de energia e de carboidratos deve considerar a glicose do dialisato, e a proteína recomendada (1,2–1,3 g/kg/dia) aumenta para 1,4–1,5 g/kg/dia na peritonite.
E) Na DP, a restrição de líquidos é obrigatória para todos os pacientes, independentemente da pressão arterial.

Questão 5. Um paciente em hemodiálise apresenta diurese residual de 400 mL/dia. Pelos critérios da aula, a prescrição de líquidos e o ganho de peso interdialítico aceitável são, respectivamente:

A) 1.400 mL/dia; até 10% do peso corporal.
B) 900 mL/dia; 3% a 5% do peso corporal.
C) No máximo 1.000 mL/dia, pois o paciente já é considerado anúrico; 3% a 5%.
D) 500 mL/dia; até 1% do peso corporal.
E) Livre demanda, já que há diurese residual; 3% a 5% do peso corporal.

Questão 6. Pelos critérios apresentados para diagnóstico de desnutrição em hemodiálise, em que a presença de um item já é suficiente, qual dos achados abaixo, isoladamente, permite o diagnóstico?

A) IMC de 24 kg/m².
B) Perda de peso não intencional de 3% em 3 meses.
C) Colesterol sérico de 140 mg/dL.
D) Percentual de gordura corporal de 15%.
E) Ingestão proteica abaixo de 0,8 g/kg/dia por 2 meses consecutivos.

Questão 7. Sobre a terapia nutricional na nefrolitíase, assinale a alternativa correta:

A) Na hiperoxalúria, recomenda-se restringir alimentos ricos em oxalato e restringir a vitamina C.
B) A restrição de cálcio alimentar é objetivo geral da terapia nutricional, independentemente do distúrbio metabólico.
C) Cálculos entre 5 e 7 mm raramente são eliminados espontaneamente.
D) Na hiperuricemia, a principal medida é restringir vitamina C e oxalatos.
E) A ingestão de líquidos deve ser reduzida para diminuir o volume urinário e a dor da cólica.

Questão 8. Paciente com IRA por sepse, em terapia renal substitutiva contínua, tem taxa de aparecimento de nitrogênio ureico (UNA) de 14 g/dia. Com base na aula, a classificação e a oferta proteica são:

A) Grupo 1 (não catabólico); 0,6–0,8 g/kg/dia.
B) Grupo 2 (catabolismo moderado); 1,0–1,2 g/kg/dia.
C) Grupo 3 (hipercatabólico); 1,3–1,5 g/kg/dia, pois a TRR não altera a necessidade.
D) Grupo 3 (hipercatabólico); 1,7–2,5 g/kg/dia.
E) Grupo 2 (catabolismo moderado); cerca de 1,5 g/kg/dia.

Questão 9. Sobre a avaliação laboratorial da função e lesão hepática, assinale a alternativa correta:

A) A AST é o marcador mais específico de lesão hepatocelular, por estar restrita ao citoplasma dos hepatócitos.
B) O tempo de protrombina/INR é o exame mais rápido para detectar insuficiência hepática aguda, enquanto a albumina, por sua meia-vida de cerca de 20 dias, reflete melhor processos crônicos.
C) A bilirrubina indireta é a fração mais sensível para detectar doença hepática, pois reflete dificuldade de excreção biliar.
D) A fosfatase alcalina é exclusiva do fígado, por isso dispensa outro exame para confirmar sua origem.
E) A GGT diminui com o consumo de álcool e com anticonvulsivantes.

Questão 10. Paciente cirrótico: bilirrubina 2,5 mg/dL, albumina 2,8 g/dL, ascite de fácil controle, sem encefalopatia, INR 1,5. A classificação de Child-Pugh e a mortalidade estimada em 1 ano são:

A) Child A (6 pontos), mortalidade < 5%.
B) Child B (7 pontos), mortalidade < 5%.
C) Child B (9 pontos), mortalidade de cerca de 20%.
D) Child C (10 pontos), mortalidade de cerca de 55%.
E) Child C (11 pontos), mortalidade de cerca de 20%.

Questão 11. Sobre a hipertensão portal e as complicações da cirrose, assinale a alternativa correta:

A) A ascite grau 1 é identificada ao exame físico pela macicez móvel positiva.
B) A peritonite bacteriana espontânea é diagnosticada pela contagem de polimorfonucleares > 500 células/mm³ e exige fonte intra-abdominal identificada.
C) A encefalopatia hepática decorre principalmente do acúmulo de ureia, resultante do desvio portossistêmico.
D) A presença de varizes esofágicas, por si só, caracteriza a cirrose como descompensada.
E) A síndrome hepatorrenal é uma falência renal funcional sem causa renal identificável, que pode ser desencadeada por paracentese de grande volume sem reposição de albumina.

Questão 12. Sobre o transplante hepático, assinale a alternativa correta:

A) No pós-operatório imediato, a terapia nutricional deve começar 12–24 h após a cirurgia, se houver estabilidade, com 10–15 kcal/kg nas primeiras 48–72 h e progressão para 30–35 kcal/kg e 1,5–2,0 g/kg de proteína em pacientes sem obesidade.
B) No pré-operatório, devem ser preferidas fórmulas enriquecidas com BCAA ou imunomoduladores, pelo benefício comprovado na morbimortalidade pós-transplante.
C) O jejum pré-operatório recomendado é de 8 horas para líquidos claros.
D) IMC > 40 kg/m² é contraindicação absoluta ao transplante.
E) Quando a via oral não é possível, deve-se aguardar a viabilidade da nutrição enteral antes de considerar a parenteral.

Questão 13. Mulher de 45 anos, esteatose à ultrassonografia, IMC 23 kg/m², circunferência da cintura 84 cm, glicemia, PA, TG e HDL normais, sem outras causas de hepatopatia. Relata consumo médio de 25 g de álcool por dia. Pela nova nomenclatura, o diagnóstico mais adequado é:

A) MASLD, pois o consumo de álcool é inferior a 30 g/dia.
B) MetALD.
C) ALD, pois qualquer consumo de álcool exclui a etiologia metabólica.
D) Não se enquadra em doença hepática esteatótica, pois o IMC é inferior a 25 kg/m².
E) MASH, pois há esteatose associada a fator metabólico.

Questão 14. Sobre triagem, investigação e prognóstico na MASLD, assinale a alternativa correta:

A) Em pessoas com obesidade, a dosagem isolada das enzimas hepáticas é o método recomendado para rastrear esteatose.
B) A MASH faz parte do fluxo diagnóstico de rotina, pois pode ser identificada pela ultrassonografia.
C) Na MASLD, as transaminases estão sempre elevadas, o que facilita o diagnóstico precoce.
D) A fibrose é o fator prognóstico para desfechos hepáticos, e o FIB-4 é usado como teste de triagem para descartar fibrose avançada.
E) O rastreamento de MASLD só deve ser considerado em adultos com IMC ≥ 30 kg/m².

Questão 15. Homem com MASLD e obesidade, peso atual 120 kg e peso ideal 75 kg, inicia dieta hipocalórica para perda de peso. Segundo a recomendação apresentada, a oferta proteica diária aproximada é:

A) 144 g (1,2 g/kg de peso atual).
B) 90 g (1,2 g/kg de peso ideal).
C) 104 g (1,2 g/kg de peso ajustado).
D) 129 g (1,5 g/kg de peso ajustado).
E) 86 g (1,0 g/kg de peso ajustado).

Questão 16. Sobre as evidências de dieta e suplementação na MASLD apresentadas em aula, assinale a alternativa correta:

A) Dietas low carb e low fat não diferiram quanto ao conteúdo de gordura hepática; a substituição de gordura saturada por insaturada foi benéfica; e, para esteatose avaliada por imagem, apenas a restrição calórica mostrou benefício.
B) A vitamina E (800 UI/dia) é terapia de primeira linha, principalmente em adultos com DM2.
C) O consumo regular de café reduziu significativamente ALT, AST e GGT nos ensaios clínicos.
D) A restrição de carboidratos abaixo de 40% do VET mostrou superioridade clara a longo prazo.
E) A dieta mediterrânea dispensa a restrição calórica, por ter efeito independente da perda de peso sobre a esteatose avaliada por imagem.

Questão 17. Paciente cirrótico Child-Pugh C, IMC de 24 kg/m², com ascite moderada e peso aferido de 70 kg. Segundo a aula, a conduta inicial e o peso a ser usado (desconto percentual) são:

A) Aplicar NRS-2002 e usar o peso aferido de 70 kg.
B) Aplicar a RFH-NPT e usar 66,5 kg (−5%).
C) Aplicar a LDUST e usar 59,5 kg (−15%).
D) Realizar avaliação nutricional direta e usar 66,5 kg (−5%).
E) Realizar avaliação nutricional direta, sem triagem, e usar 63 kg (−10%).

Questão 18. Sobre a avaliação da composição corporal e da funcionalidade na cirrose, assinale a alternativa correta:

A) A circunferência da panturrilha é a medida preferida em pacientes com edema de membros inferiores.
B) A tomografia em L3 é o método recomendado, por quantificar a massa muscular sem influência do acúmulo de fluidos, enquanto a bioimpedância tende a superestimar a massa livre de gordura.
C) Pela DEXA, o índice de massa muscular apendicular é válido mesmo com edema importante de membros.
D) A força de preensão reduzida só deve motivar intervenção depois da confirmação de massa muscular reduzida por exame de imagem.
E) A perda de massa muscular só é esperada a partir do Child-Pugh C.

Questão 19. Paciente com cirrose descompensada, desnutrido, com ascite moderada e sódio sérico de 132 mmol/L, ingerindo cerca de 65% das necessidades por via oral. A conduta mais coerente com as recomendações é:

A) 25 kcal/kg e restrição de sódio < 1,5 g/dia, para acelerar a resolução da ascite.
B) Dieta hipocalórica para perda de peso, já que o peso aferido está aumentado pela ascite.
C) Restrição hídrica de 800 mL/dia e nutrição enteral, por causa da ascite.
D) 30–35 kcal/kg e 1,2–1,5 g/kg de proteína, sódio < 2 g/dia sem restrição hídrica, fracionamento com ceia e suplemento oral.
E) Nutrição parenteral, pois a ascite impede o uso do trato gastrointestinal.

Questão 20. Sobre o manejo nutricional da encefalopatia hepática, assinale a alternativa correta:

A) A ingestão proteica deve ser restringida a 0,5 g/kg/dia como tratamento padrão, pois reduz a gravidade da encefalopatia.
B) A suplementação de zinco é tratamento padrão da encefalopatia e deve ser mantida indefinidamente.
C) Os BCAA reduziram a ocorrência de encefalopatia, sem efeito sobre a mortalidade; são metabolizados no músculo, onde ajudam a fixar a amônia, e a ESPEN recomenda 0,25 g/kg/dia por via oral na cirrose avançada.
D) A restrição de proteína animal deve ser orientada a todos os pacientes, pois a carne gera mais amônia.
E) Na cirrose, a razão entre aminoácidos de cadeia ramificada e aromáticos aumenta para valores acima de 3,5.

Gabarito comentado

1. C — A tríade do manejo é proteinúria–edema–hiperlipidemia. A dieta **normoproteica** mantém o balanço nitrogenado positivo, ajuda a elevar a albumina e melhora o edema; lipídios **< 30% VET**, com restrição de saturados e mais fibras. **A/E:** a hiperproteica aumenta catabolismo e perda proteica e pode acelerar a progressão; E erra também a prevalência de dislipidemia (70–100%). **B:** restrição com cetoácidos é estratégia da DRC 3–5, não da síndrome nefrótica. **D:** lipídios 30–35% e restrição hídrica não constam como recomendação da SN.

2. B — Alteração por > 3 meses; TFG 45–59 = **G3a**; albuminúria 30–300 mg/g = **A2**. **A:** G2 é 60–89. **C:** G3b é 30–44 e A3 é > 300. **D:** TFG < 60 por > 3 meses já define DRC. **E:** A1 é < 30 mg/g.

3. C — Dose de 1 comprimido/5 kg/dia; os cetoácidos recebem N por transaminação, formando AA essenciais e reduzindo compostos tóxicos. **A:** a opção 02 é para estágios **4 ou 5** (a 01 cobre 3–5). **B:** ambas exigem paciente **sem diabetes** (com DM: 0,6–0,8 g/kg). **D:** hospitalização < 2 semanas e infecção ativa tornam o paciente **metabolicamente instável**. **E:** o efeito é **diminuir** a disponibilidade de N.

4. D — Na DP, energia (25–35 kcal/kg) e CHO (35% VET por VO) incluem a glicose do dialisato; proteína 1,2–1,3, chegando a 1,4–1,5 em repleção/peritonite. **A:** CAPD = **2,0 por semana**. **B:** HD = **1,0–1,2** (menor que DP). **C:** P na HD = 700 mg; 1.000–1.200 mg é da DP. **E:** na DP, restrição só se PA elevada e edema.

5. B — Com diurese: **500 mL + diurese** = 900 mL; ganho interdialítico aceitável 3–5%. **C:** o limite de 1.000 mL é para anúricos. **A, D, E:** valores sem respaldo nos slides.

6. E — Ingestão proteica < 0,8 g/kg/dia por 2 meses consecutivos é um dos critérios. Os demais estão fora dos pontos de corte: IMC < 23; perda > 5% em 3 meses; colesterol < 100 mg/dL; gordura < 10%.

7. A — Hiperoxalúria: restringir oxalatos **e vitamina C**. **B:** o objetivo geral é **evitar a restrição de cálcio** (controle de Ca só na hipercalciúria absortiva tipo II). **C:** 5–7 mm são eliminados em ~50%; > 7 mm raramente. **D:** na hiperuricemia restringem-se purinas. **E:** a meta é **aumentar** líquidos.

8. D — UNA > 10 g/dia (trauma, queimados, sepse) = **grupo 3**; em TRR contínua: **1,7–2,5 g/kg/dia**. **C:** 1,3–1,5 é para hipercatabólicos **sem** TRR. **E:** ~1,5 é TRR **intermitente**, e grupo 2 corresponde a UNA 5–10. **A/B:** classificação e valores incorretos.

9. B — TP/INR é o exame mais rápido e confiável para lesão aguda; a albumina (meia-vida ~20 dias) reflete processos crônicos. **A:** a ALT é a mais específica; a AST também está em músculo, coração e rins. **C:** a bilirrubina **direta** é a mais sensível e reflete dificuldade de excreção. **D:** FA também está em ossos e placenta; a GGT confirma a origem hepática. **E:** a GGT **aumenta** com álcool e anticonvulsivantes.

10. C — Bilirrubina 2,5 = 2; albumina 2,8 = 3; ascite fácil = 2; sem EH = 1; INR 1,5 = 1 → **9 pontos = Child B**, mortalidade ~20% em 1 ano. As demais erram a soma ou associam classe e mortalidade de forma errada (A < 5%; C 55%).

11. E — Definição e gatilho da síndrome hepatorrenal conforme a aula. **A:** grau 1 é detectável só por imagem (macicez móvel negativa). **B:** PBE = PMN > **250**/mm³, **sem** fonte intra-abdominal tratável. **C:** a EH decorre do acúmulo de **amônia**. **D:** a descompensação por varizes ocorre quando há **sangramento**.

12. A — Corresponde às recomendações do pós-operatório imediato. **B:** produtos especializados **não** têm resultados consistentes; usar fórmulas padrão. **C:** líquidos até **2 h** antes (sólidos 6 h). **D:** IMC > 40 é contraindicação **relativa**. **E:** iniciar NP precocemente é melhor que esperar a NE.

13. B — Há esteatose + ≥ 1 fator cardiometabólico (CC > 80 cm em mulher). Em mulheres, 20–50 g/dia caracteriza **MetALD**. **A:** 30 g é o limite inferior para **homens**. **C:** ALD é acima de 50 g/dia (M). **D:** basta um fator; a CC já preenche. **E:** MASH exige inflamação lobular e balonização (biópsia).

14. D — A fibrose é o fator prognóstico para desfechos hepáticos, e o FIB-4 é triagem para descartar fibrose avançada. **A:** a dosagem isolada de enzimas **não** é recomendada para rastreio. **B:** MASH só é identificada por biópsia, por isso não está no fluxo. **C:** enzimas podem estar normais. **E:** rastrear se IMC **> 25**.

15. C — Peso ajustado = (120 − 75) × 0,25 + 75 = 86,25 kg; 1,2 g/kg → ~104 g/dia. **A** usa peso atual; **B**, peso ideal; **D** e **E** usam fatores diferentes do recomendado (1,2 g/kg de peso ajustado).

16. A — Resume a meta-análise de macronutrientes e a de dieta mediterrânea/restrição calórica. **B:** vitamina E não é 1ª linha, e o uso é focado em adultos **sem** DM2 com MASH. **C:** não houve diferença em ALT/AST/GGT. **D:** a superioridade da restrição de CHO < 40% no longo prazo **não é clara**. **E:** na esteatose por imagem, só a restrição calórica teve benefício; ela **deve fazer parte** da intervenção.

17. E — Child-Pugh C (e/ou IMC < 18,5) = alto risco → avaliação direta, sem triagem. Ascite moderada: desconto de **10%** → 63 kg. **A, B, C:** aplicam triagem desnecessária (e A não corrige o peso). **D:** acerta a conduta, mas −5% é o desconto da ascite **leve**.

18. B — A TC em L3 é a recomendada e não sofre influência de fluidos; BIA (e DEXA) superestimam a MLG. **A:** a CP só deve ser usada em pacientes **sem** edema. **C:** IMMA é alternativa na ascite **sem** edema de membros. **D:** FAM reduzida **já justifica** intervir. **E:** espera-se perda muscular **mesmo no Child A**.

19. D — Desnutrido/descompensado: 30–35 kcal/kg e 1,2–1,5 g/kg; Na < 2 g/dia; restrição hídrica só se Na < 120–125 mmol/L; fracionamento com ceia; VO < 70% → suplemento oral. **A:** < 1,5 g Na é desaconselhado (↓ palatabilidade). **B:** não se faz perda de peso em descompensados. **C:** sem hiponatremia grave não há restrição hídrica, e VO de 65% indica SNO (enteral quando < 60%). **E:** ascite não inviabiliza o TGI.

20. C — Cochrane: BCAA ↓ EH sem efeito na mortalidade; metabolizados no músculo (glutamato → fixa amônia → glutamina); ESPEN 0,25 g/kg/dia VO na cirrose avançada. **A:** a restrição **não** reduziu a gravidade e pode piorar o catabolismo. **B:** zinco **não** é tratamento padrão e não há dose de manutenção definida. **D:** restrição de proteína animal só para quem tem **intolerância**. **E:** a razão **cai** para < 1,0 na cirrose (normal 3,0–3,5).